

Cykl PPU — *model Carnesa (adaptacja)*

Każdy epizod PPU ma cztery fazy: zaabsorbowanie, rytualizacja, akt, rozpacz. Rozpoznanie fazy = możliwość interwencji w konkretnym punkcie.

CZAS: 25 min Psychoedukacja + autorefleksja

ŹRÓDŁO: Carnes (1983, „Out of the Shadows”); adaptacja współczesna SAA, ICD-11

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza klasyczny **czterofazowy cykl** uzależnienia seksualnego Patricka Carnesa (1983), zaadaptowany do współczesnego rozumienia PPU. Cztery fazy: 1) **zaabsorbowanie** (fantazje, myśli zajmujące), 2) **rytualizacja** (przygotowania, „jeszcze tylko”), 3) **akt** (samo zachowanie), 4) **rozpacz** (wstyd, „nigdy więcej”). Karta pokazuje, jak każda faza działa, gdzie dokładnie można **przerwać cykl**, oraz dlaczego im wcześniej, tym łatwiej.

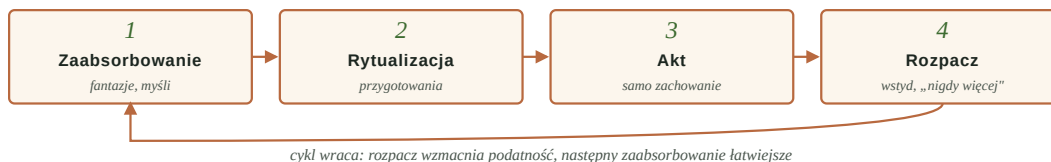
DLACZEGO TO DZIAŁA

Carnes (1983) wprowadził model na podstawie obserwacji 1000+ pacjentów Sexaholics Anonymous. Model jest **opisowy, nie wyjaśniający** — nie tłumaczy etiologii (od tego I-PACE, dual control), ale pokazuje **strukturę epizodu**. Praktyczna wartość: pacjent uczy się **rozpoznawać fazy u siebie**. To pozwala na interwencję **przed** aktem — w fazie 1 lub 2, gdzie samokontrola jest jeszcze możliwa. Po wejściu w fazę 3 mózg uzależniony „nie słyszy argumentów”. Współczesne badania (Reid i wsp. 2012, Walton i wsp. 2017) potwierdzają model: epizody PPU mają regularną sekwencję, predyktownie identyfikowalną — co czyni je **przerwalnymi**.

01



Cztery fazy cyklu



02



Każda faza — co dzieje się, co robić

1 · ZAABSORBOWANIE

Pojawia się fantazja, natrętna myśl, „kątem oka” sięga po telefon. Pobudzenie SES rośnie. **Najwięcej kontroli** — można jeszcze przekierować uwagę.

Interwencja: defuzja („zauważam myśl”), dystrakcja, kontakt z osobą, ruch fizyczny.

2 · RYTUALIZACJA

„Tylko sprawdzę”, „jeszcze tylko 5 minut”, szukanie ustronnego miejsca, wieczorne przygotowania. Pobudzenie rośnie, samokontrola spada.

Interwencja: reguła „15 minut”, commitment device, hands-off rule, fizyczne wyjście z pomieszczenia.

3 · AKT

Samo zachowanie. Kora przedczołowa „wycofała się”, uruchomił się układ nagrody. Niewielka szansa zatrzymania.

Interwencja: w samym akcie — minimalna; cel: *skrócić*, „półwyłączenie” (przerwanie, zatrzymanie się w trakcie).

4 · ROZPACZ

Wstyd, „nigdy więcej”, katastrofizacja, myśli samokrytyczne. Paradoks: rozpacz zwiększa ryzyko kolejnego epizodu (wzmacnia podatność).

Interwencja: aut sympatia, brak biczowania, kontakt z osobą z sieci, refleksja zamiast samokrytyki.

03 Twój ostatni epizod — rozłóż na fazy

Wybierz *jeden konkretny epizod* z ostatniego tygodnia. Rozłóż go na 4 fazy. Cel: **znaleźć moment**, w którym mogłeś/-aś przerwać, i co wtedy zrobiłeś/-aś inaczej.

FAZA 1 • ZAABSORBOWANIE

— kiedy zaczęło się, jakie myśli

FAZA 2 • RYTUALIZACJA

— co robiłem/-am, ile to trwało

FAZA 3 • AKT

— ile minut, co konkretnie

FAZA 4 • ROZPACZ

— co czułem/-am, co myślałem/-am o sobie

04 Mój punkt interwencji — następnym razem

W KTÓREJ FAZIE NAJŁATWIEJ MI PRZERWAĆ

— gdzie mam najwięcej kontroli

KONKRETNA INTERWENCJA

— co zrobię w tej fazie następnym razem

Klucz: Walton i wsp. (2017, n=420, analiza dziennikowa) wykazali, że **91% epizodów PPU** ma rozpoznawalną sekwencję faz Carnesa. Pacjenci, którzy *nauczą się* rozpoznawać fazy u siebie, redukują częstotliwość epizodów o **40-55%** w 3-miesięcznej obserwacji — bez innych interwencji, samym *uświadomieniem*. Mechanizm: rozpoznanie fazy 1 lub 2 daje czas na włączenie świadomej decyzji, zanim mózg „uzależnieniowy” przejmie kontrolę. Im wcześniejsza interwencja, tym większa skuteczność. Faza 1 = 80% szans powstrzymania, faza 2 = 50%, faza 3 = 10%, faza 4 = nie interwencja, tylko regeneracja.